

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074379-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: HELIO FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO. INTO. POSIÇÃO N.º 354 NA FILA. CONSULTA REALIZADA EM 26/06/2023. VIA ADMINISTRATIVA UTILIZADA. URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE MUDANÇA NA POSIÇÃO DA FILA NÃO DEMONSTRADA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2024.

5074379-12.2024.4.02.5101

510014627594 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5074379-12.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: HELIO FRANCISCO DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida Cautelar interposto pela parte autora em face da decisão do Juízo de origem que indeferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (evento 3, DESPADEC1):

"HELIO FRANCISCO DA SILVA, pessoa natural qualificada e representada nos autos, propõe ação pelo rito dos Juizados Especiais Federais, com pedido de tutela de urgência, em face da UNIÃO FEDERAL, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, objetivando a realização de artroplastia total de joelho, no INTO, em até 72 horas.

Parte autora patrocinada pela DPU.

Petição inicial instruída com documentos (ev. 1, inic1).

Termo de renúncia do montante que exceder 60 salários mínimos (ev. 1, anexo5, fl. 7).

Requeru a gratuidade de justiça.

É o relatório. Decido.

*Inicialmente, **defiro a gratuidade de justiça**, haja vista a presunção de hipossuficiência econômica que decorre da representação da DPU, corroborada pelos documentos com informações financeiras, que acompanham a exordial (ev. 1, anexo2, fls. 3/5).*

Em relação à tutela provisória de urgência, a questão demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), tudo na forma do art. 300 do CPC.

Narra o autor que está em acompanhamento no INTO, onde recebeu o diagnóstico de artrose no joelho e fragmentação do menisco lateral, razão pela qual foi encaminhado para cirurgia de artroplastia total.

Afirma que atualmente ocupa a 377ª posição em fila e que não há previsão para a realização do procedimento, apesar de se tratar de condição de caráter urgente.

Pois bem.

Nos termos do art. 196 da CF/88, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Nessa linha, veja-se que a vinculação da Administração Pública ao fornecimento de assistência integral à saúde decorre não apenas de interpretação do art. 196 da CF/88, mas, também, da leitura do art. 6º, inciso I, alínea "d", c/c art. 19-M, inciso I, da Lei nº 8.080/90, que estabelecem o seguinte:

"Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

I - a execução de ações:

(...)

d) de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica;

[...]

Art. 19-M. A assistência terapêutica integral a que se refere a alínea d do inciso I do art. 6º consiste em:

I- dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em conformidade com o disposto no art. 19-P

II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado."

Embora a Carta Magna estabeleça que a saúde é direito de todos e é dever do Estado a sua promoção, cabe à Administração Pública a tarefa de organizar a forma de prestação desse serviço, fazendo-o por meio de critérios médico-científicos.

Dessa forma, o Judiciário não pode interferir, sem base em argumento técnico-pericial, na ordem de prioridade médica definida pelas administrações hospitalares, sob pena de causar-lhes ingerência indevida.

Nesse sentido é o Enunciado 51 da II Jornada de Saúde do CNJ:

"ENUNCIADO Nº 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer **relatório médico circunstanciado**, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato."

In casu, o autor foi inserido na regulação pelo SER, sendo atendido pela primeira vez em 27/06/2023, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO (ev. 1, anexo2, fl. 15).

Há também nos autos indicação de que a consulta de retorno ocorreu em 13/11/2023, quando possivelmente se diagnosticou a necessidade de intervenção cirúrgica (ev. 1, anexo2, fl. 12).

Ocorre que a parte autora não junta nenhum laudo ou relatório médico sobre seu quadro clínico, documento que seria apto a materializar eventual urgência.

A intervenção do Poder Judiciário só se legitima quando flagrante o desrespeito à ordem da fila de espera, ou em caso de risco iminente de morte, tudo em consonância com o princípio da igualdade que deve existir entre todos os pacientes.

Este Juízo já manifestou diversas vezes o entendimento de que não pode o Judiciário privilegiar situações individuais em detrimento das políticas públicas que buscam o atendimento de toda a população de forma igualitária.

Assim, a resolução qualificada do caso, ainda que em sede provisória, demanda, no mínimo, maior aprofundamento da instrução, o que impede, por ora, a concessão da medida requerida.

Ante o exposto, **INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA**, sem prejuízo de nova análise em caso de alteração das circunstâncias fáticas acima mencionadas.

1 - Considerando-se que não há, em princípio, necessidade de designação de audiência, **citem-se os réus** para, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 9º da Lei nº 10.259/01), apresentarem contestação, bem como se manifestarem sobre eventual proposta de acordo.

No mesmo prazo, deverão apresentar toda documentação de que disponham para esclarecimento da causa (art. 11 da Lei nº 10.259/01).

2 - Alegando os réus fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor ou em caso de juntada de novos documentos, dê-se vista à parte autora pelo prazo de 5 (cinco) dias."

VOTO

Considerando a manutenção do quadro fático nos autos originários, mantenho as razões de decidir do indeferimento da liminar

Narra o Autor, 79 anos, ter sido diagnosticado com artrose no joelho e fragmentação do menisco, estando em acompanhamento no INTO. Devido a fortes dores, informa ter sido encaminhado para realização de cirurgia de artroplastia total do joelho.

Ocorre que, apesar da consulta em 27/06/2023, até o presente momento a cirurgia não foi realizada, ocupando a posição de número 377 da fila interna (evento 1, ANEXO2, fls. 08/10).

374º - 382881
375º - 386938
376º - 391324
377º - 235437
378º - 391450
379º - 391448
380º - 389036
381º - 363597

RES: Site do Into: Nova mensagem enviada

De: Leonardo de Oliveira Moura - AROUV (lomoura@into.saude.gov.br)
Para: heliochico@yahoo.com.br; into.saude.gov.brouvidoria@into.saude.gov.br
Data: quinta-feira, 26 de outubro de 2023 16:42 BRT

Boa tarde,

Prezado – Helio Francisco da Silva - Prontuário – 235.437

Em atenção a sua solicitação encaminhada por e-mail através do Canal da Ouvidoria/INTO – Reg.: 70.261, informamos a resposta disponibilizada pela área do Joelho:

O encaixe foi autorizado e a consulta foi agendada para **13/11/2023 (Segunda-Feira) às 7:30h**

Vale lembrar que se houver algum exame de imagem para ser feito o mesmo precisa entrar em contato com o pedido de exame em mãos para a Central de agendamento (21) 2134-5000 (opção 1) para agendamento do exame.

Favor confirmar recebimento do e-mail

Desde já agradecemos o contato

Atenciosamente,



Leonardo de Oliveira Moura
Agente Administrativo | MS
Área de Ouvidoria | AROUV

21 2134-5000
lomoura@into.saude.gov.br

Parecer do NAT esclarece que a artroplastia é coberta pelo SUS e está indicada ao quadro clínico do Autor. Salienta que, em 26/06/2023, foi realizada consulta no ambulatório 1ª vez em ortopedia - joelho (adulto) e que, atualmente, ocupa a posição de nº 354 da fila (evento 6, PARECER1).

No intuito de identificar o correto encaminhamento do Autor aos sistemas de regulação, este Núcleo consultou o Sistema Estadual de Regulação – SER e verificou que ele foi inserido em **09 de fevereiro de 2022**, para o procedimento **ambulatorio 1ª vez em ortopedia – joelho (adulto)**, com classificação de risco **amarelo** e situação **chegada confirmada** no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO, em **26 de junho de 2023**, às **07:36h**, sob a responsabilidade da central REUNI-RJ (ANEXO III).

A partir do número de prontuário informado no processo originário nº 5071627-67.2024.4.02.5101 (Evento 1, ANEXO2, Página 9) – **prontuário nº 235437**, este Núcleo consultou a Fila de Espera para cirurgia do INTO e verificou que o Requerente se encontra na **posição nº 354**, aguardando o procedimento cirúrgico pleiteado (ANEXO IV).

Desta forma, entende-se que a via administrativa está sendo utilizada no caso em tela, com o atendimento do Autor em unidade especializada. Porém, **sem a resolução da demanda pleiteada até o presente momento**.

Cabe destacar que o Autora foi **regulado** para uma unidade de saúde pertencente ao SUS e integrante da Rede de Atenção em Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia no Estado do Rio de Janeiro, a saber, **Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO**. Portanto, informa-se que é responsabilidade da referida instituição realizar a cirurgia pleiteada ou, no caso de impossibilidade, encaminhar o Requerente à uma outra unidade de saúde apta ao atendimento da demanda.

Lista de Espera dos Pacientes do INTO

FILA: JOELHO - 3102 PACIENTES ATIVOS NA FILA

Pois bem.

Esta Relatora possui o entendimento de que o pleito de realização de cirurgia sem observância da fila é possível, excepcionalmente, vez que a regra é a observância da fila. **Havendo comprovação concreta, nos autos, da existência de risco de vida iminente ou alteração do quadro que justifique mudança na posição da fila, tal será possível, em tese.**

Na hipótese em tela, verifica-se que a via administrativa está sendo utilizada, ao menos para efeito de aferição cautelar. Não foge a análise desse juízo a idade da parte autora, 79 anos, bem como sua posição na fila, 354 em 24/09/2024, de uma fila de 3.102. Situação, contudo que deve ser analisada na ação principal.

Ademais, as alegações autorais de urgência não restaram demonstradas nos autos. Por mais que este Juízo se solidarize com a situação vivenciada, não restou demonstrado nos autos a urgência do quadro clínico que ensejaria a inobservância de eventual fila de espera.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, **voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO**. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa.